Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Cystite simple non compliquée – Femme < 65 ans

Femme de 18 à 64 ans · symptômes exprimés par la patiente · BU puis antibiotique sur ce protocole

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · fièvre avec frissons, confusion, marbrures, PAS ≤ 100 mmHg, FR ≥ 22/min ; allergie avec gêne respiratoire ou malaise.

J'applique si

- Brûlures mictionnelles, pollakiurie et/ou urgenturies **exprimées par la patiente**.
- **BU positive** (leucocytes et/ou nitrites), sans fièvre, frissons, douleur lombaire ni vomissements.

Je n'applique pas → avis médical

- Homme, grossesse, < 18 ou ≥ 65 ans, patiente **non communicante**.
- Vessie neurologique, résidu, lithiase, sonde, geste récent ; immunodépression grave ; DFG < 30.
- Cystite **récidivante** (≥ 4 / 12 mois), germe résistant connu.
- BU positive **sans symptôme** : aucun antibiotique (colonisation).

J'agis

RÔLE PROPRE

1. **BU** sur urines fraîches du milieu de jet ; T°, FC, PA, douleur lombaire ; grossesse si doute.
2. Allergies (pénicillines), DFG, épisodes et antibiotiques des 12 derniers mois.

SUR CE PROTOCOLE

3. **Fosfomycine** en 1re intention ; **pivmécillinam** si allergie ou CI (carte ci-contre).

RÔLE PROPRE

4. Faire boire si autorisé ; douleur : « Paracétamol – Douleur et/ou fièvre » ; **ECBU** (prescription IDE) si échec.

SUR AVIS MÉDICAL

5. Tout autre antibiotique : prescription médicale écrite.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Antibiotique (un seul)

1re intention

Fosfomycine 3 g (Monuril)

dose unique, à jeun (2–3 h des repas), au coucher

Allergie ou CI

Pivmécillinam 400 mg × 2/j, **3 j**

- Selexid 200 mg : 2 cp par prise, au milieu du repas, grand verre d'eau, rester assise 30 min
- CI : allergie aux pénicillines ou anaphylaxie à une bêta-lactamine, vidange œsophagienne, déficit en carnitine

J'appelle le médecin

- Fièvre, douleur lombaire, vomissements : pyélonéphrite → avis **sans délai**.
- Persistance ou aggravation **après 3 jours** ; récidive dans les 2 semaines (ECBU).

Je surveille et je trace

- Symptômes, BU, molécule, dose, heure, tolérance (éruption, diarrhée, vomissements).
- Réévaluer à **72 h** : signes urinaires, T°, douleur lombaire.

À retenir : Protocole limité à la cystite simple de la femme de moins de 65 ans. Sujet âgé, homme, situation atypique : ECBU et prescription médicale.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, cystite aiguë simple, à risque de complication ou récidivante de la femme (MAJ 13/05/2025) ; SPILF, Info-antibio n° 107 (12/2025) ; RCP Monuril 3 g (ANSM, MAJ 25/07/2025), Selexid 200 mg (MAJ 27/05/2026 : 5 j ; 3 j retenus selon HAS) ; arrêté du 26/06/2026 (actes et prescriptions IDE).

Réf. DOTR-IDE-CYST | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature